2º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENFERMAGEM DE FAMÍLIA E COMUNIDADE
2º CONGRESSO ALAGOANO DE MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE

Estratégia Saúde da Família: a potência brasileira que inspira o mundo
30 de abril a 2 de maio de 2026
MACEIÓ • ALAGOAS

Realização
ABEFACO
AAMFC

Fatores associados ao risco cardiovascular e condições hepáticas em idosos com doenças crônicas da atenção primária em saúde

Giovanna de Sá Lima Ferreira[1], Cris Renata Grou Volpe[2]
[1] Universidade de Brasília

Fonte: Brunomarcelos

Este artigo visa destacar a importância da **avaliação conjunta de marcadores hepáticos e perfil lipídico** e o papel da enfermagem na prevenção, por meio de educação em saúde, controle de fatores de risco e promoção de hábitos saudáveis.

INTRODUÇÃO

Unidade Básica de Saúde visa promover e prevenir agravos à saúde. Com uso de indicadores, as condutas clínicas e os desfechos dos pacientes são otimizados.

OBJETIVO

Analisar fatores associados ao risco cardiovascular e condições hepáticas em idosos com doenças crônicas na atenção primária.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo transversal, descritivo e quantitativo realizado em uma UBS do DF, em julho de 2024, com 58 idosos que atendiam aos critérios de inclusão. Utilizou-se instrumento estruturado para avaliar variáveis sociodemográficas, clínicas e antropométricas, além de coleta de sangue em jejum, bioimpedância e análise do risco cardiovascular pela escala de Framingham.

RESULTADOS

Variável	Categoria	n	%
Sexo	Masculino	16	27,6%
	Feminino	42	72,4%
Idade	< 70 anos	32	55,2%
	≥ 70 anos	26	44,8%
Cor	Branca	16	27,6%
	Parda	30	51,7%
	Negra	12	20,7%
Tabagismo	Não	27	46,6%
	Sim	10	17,2%
	Ex-tabagista	21	36,2%
Etilismo	Não	37	63,8%
	Sim	5	8,6%
	Às vezes	16	27,6%
Sedentarismo	Não	25	43,1%
	Sim	20	34,5%
	Às vezes	13	22,4%
Medicamentos DM	1 medicação	43	74,1%
	2 medicamentos	13	22,4%
	0 medicamentos	1	1,7%
	5 medicamentos	1	1,7%

Tabela 1- Caracterização dos participantes (n=58). Brasília, 2024.

TABELA 2 – CARACTERIZAÇÃO CLÍNICA DOS PARTICIPANTES POR RISCO CARDIOVASCULAR

Variável	RCV Baixo		RCV Moderado		RCV Alto		Valor p
	M	DP	M	DP	M	DP	
IMC	27,90	4,10	29,40	4,80	31,80	5,20	0,032
PGC	42,15	7,82	43,67	5,27	40,22	8,15	0,104
CC	92,40	10,30	98,70	11,40	104,30	12,10	0,019
CP	35,90	3,78	34,14	3,49	35,61	4,84	0,210
MM	23,67	6,46	38,86	62,40	40,10	53,96	0,002
GLIC	98,30	18,40	118,40	35,60	142,70	42,90	0,006
HbA1c	5,60	0,40	6,20	0,70	7,10	1,30	0,000
COLEST	172,50	32,20	185,40	40,30	208,70	45,60	0,045
TRIGL	121,40	42,70	148,20	58,30	192,80	67,40	0,009
HDL	58,80	9,20	51,40	8,80	46,30	7,90	0,001
LDL	95,10	28,50	108,80	36,80	125,60	41,20	0,040

Distribuição: Baixo (n=8), Moderado (n=20), Alto (n=30) | Total: 58 participantes

Tabela 2- Caracterização clínica dos participantes por risco cardiovascular

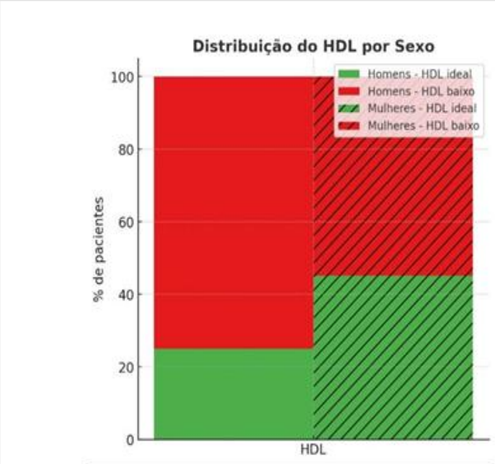

Figura 3- Distribuição do HDL por sexo

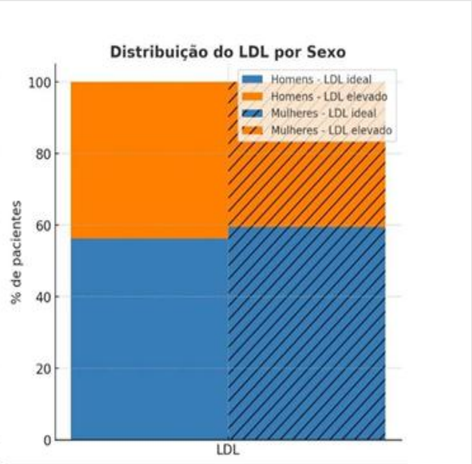

Figura 4- Distribuição de LDL por sexo

O estudo identificou alto risco cardiovascular, semelhante a Pimenta et al. (2014), que observaram múltiplos fatores em hipertensos. Jung et al. (2022) confirmaram associação entre alterações de colesterol e mortalidade por DCV. Os exames apontam resultados laboratoriais fora do padrão ideal. A atuação da enfermagem se mostra excepcional na abordagem e melhora da condição clínica dos pacientes.

CONCLUSÃO

A população idosa apresenta alto risco cardiovascular especialmente os homens, devido ao acúmulo progressão de fatores. Alterações nos níveis de HDL e LDL têm grande relevância nesse grupo. Destaca-se papel do enfermeiro no manejo adequado, visa melhor qualidade de vida.

Universidade de Brasília
Giovanna de Sá
Graduanda de enfermagem

E-mail: giovannadesa15@gmail.com